テスト用架空事例

認定結果(テスト用設定)

要介護度	要介護4
認定日	令和8年9月16日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年3月31日(6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年8月26日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護3)		
対象者氏名	北村 武雄 (きたむら たけお)	性別	男
生年月日	昭和19年(1944年)4月25日	年齢	82歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 訪問看護(週2回・呼吸状態の観察、酸素の管理)、訪問介護(身体介護・週5回)、訪問入浴介護(週1回)、福祉用具貸与(特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす)。医療 在宅酸素療法、訪問診療(月2回)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	妻(80歳)と二人暮らし。主な介護者は妻。長男(54歳)は県内に住み、月2回訪問。
居住環境	マンションの3階(エレベーターあり)。寝室にベッド、ベッドの横にポータブルトイレ。
使用している機器等	在宅酸素(安静時2L/分・労作時3L/分)、パルスオキシメーター、特殊寝台、車いす、ポータブルトイレ(購入済み)。
生活歴	長距離トラックの運転手として働いた。20歳から70歳まで1日40本の喫煙。
本人・家族の主訴	本人:「息が苦しいのが一番つらい。入院はしたくない。」 妻:「夜中に息が苦しくなったとき、どうしたらいいか不安。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-5 座位保持	できる (自分の手で支えればできる) 支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる (何か支えがあればできる) できない
1-7 歩行	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助 (全介助) 行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助 (全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-2 移動	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-3 えん下	(できる) 見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-6 排便	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-7 口腔清潔	介助されていない (一部介助) 全介助
2-8 洗顔	介助されていない (一部介助) 全介助
2-9 整髪	介助されていない (一部介助) 全介助
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-12 外出頻度	週1回以上 (月1回以上) 月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる) ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる) できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる) できない
3-4 短期記憶	(できる) できない
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	(できる) できない
3-7 場所の理解	(できる) できない
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない) ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない) ときどきある　ある
4-2 作話	(ない) ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない) ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない) ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない) ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない) ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない) ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない) ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない) ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない) ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない) ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない) ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない) ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない) ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない) ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない (一部介助) 全介助
5-2 金銭の管理	介助されていない (一部介助) 全介助
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる)) 特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない) ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　■酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　A2　(B1)　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　(Ⅰ)　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-3・1-4 ベッド柵につかまって行うが、動くと息切れが強く、休みながら行う。 1-5 座っているとき、ベッドに手をついて体を支える。 1-7 数歩で息切れが強くなり(SpO2 85%前後まで低下)、歩くことはできない。 1-10 訪問入浴で全身を洗ってもらう。
第2群 生活機能	2-1 ベッドから車いす・ポータブルトイレへは、ベッド柵につかまり自分で乗り移る。妻が見守る。 2-2 室内の移動は車いすで、妻が押している。 2-4 ベッドの端に座り、自分で食べる。 2-5・2-6 ポータブルトイレを使い、後始末とズボンの上げ下ろしを妻が行う。 2-12 月2回の受診は、介護タクシーで車いすのまま行っている。
第3群 認知機能	3-1〜3-7 すべて答えられた。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。息苦しさから不安が強くなることがある。
第5群 社会生活への適応	5-1 吸入薬と内服薬は妻が準備し、本人が使う。 5-2 通帳は妻が管理している。
特別な医療	酸素療法:在宅酸素(安静時2L/分、労作時3L/分)を24時間使用している。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	北村 武雄 (男・82歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)	約12年前
2. 心房細動	約6年前
3. 慢性心不全	約3年前

(2)症状としての安定性	不安定
(3)経過及び治療内容	COPDが進行し、令和5年から在宅酸素療法を開始。この1年でCOPDの急性増悪(肺炎)により2回入院(直近は令和8年6月)。心房細動に伴う心不全もあり、わずかな動作で呼吸困難・SpO2低下をきたす。 投薬:長時間作用性気管支拡張薬(吸入)、抗凝固薬、利尿薬、去痰薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

酸素療法

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):B1 認知症高齢者の日常生活自立度: Ⅰ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	不安(呼吸困難時)
(5)身体の状態	利き腕:右/身長165cm・体重48kg(この1年で5kg減少)/呼吸困難(MRC 5)/下肢の筋力低下/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない/車いす:主に他人が操作/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:不良/留意点:少量で高カロリーの食事、食事中の息切れに注意
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	COPDの急性増悪・肺炎、心不全の悪化、低栄養、抗凝固薬による出血 → 感染予防、酸素量の管理、早めの受診、栄養補助食品
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できない
(5)医学的管理の必要性	訪問診療、訪問看護
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	血圧・SpO2:動作の前後で確認(SpO2 88%未満は休息)/移動:息切れに注意/入浴:訪問入浴で短時間に
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

症状は不安定で、急性増悪による入院を繰り返している。訪問診療・訪問看護と連携し、呼吸状態の悪化に早く気づける体制が必要。